Bài 38 VẾT THƯƠNG BỤNG

Trần Hiếu Học
Quách Văn Kiên

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được chẩn đoán xác định vết thương bụng.

2. Trình bày được nguyên tắc điều trị vết thương bụng.

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đặt vấn đề

Vết thương thấu bụng là vết thương gây tổn thương các lớp của thành bụng, có rách phúc mạc khiến ổ bụng thông với môi trường ngoài. Nếu vết thương không gây rách lá phúc mạc thì gọi là vết thương thành bụng. Vết thương thành bụng chỉ là vết thương phần mềm nhưng nhiều khi khó phân biệt với vết thương bụng.

Cần chú ý vết thương bụng khi lỗ vào không ở trên thành bụng như vết thương ngực - bụng, vết thương tầng sinh môn - bụng. Vết thương do hỏa khí thường phức tạp và nặng hơn vết thương do bạch khí.

Về nguyên tắc điều trị vết thương bụng là phẫu thuật, tuy nhiên ngày nay nhờ các tiến bộ trong chẩn đoán mà tỷ lệ điều trị không mổ vết thương bụng ngày càng tăng.

2. Giải phẫu bệnh

2.1. Tác nhân gây tổn thương

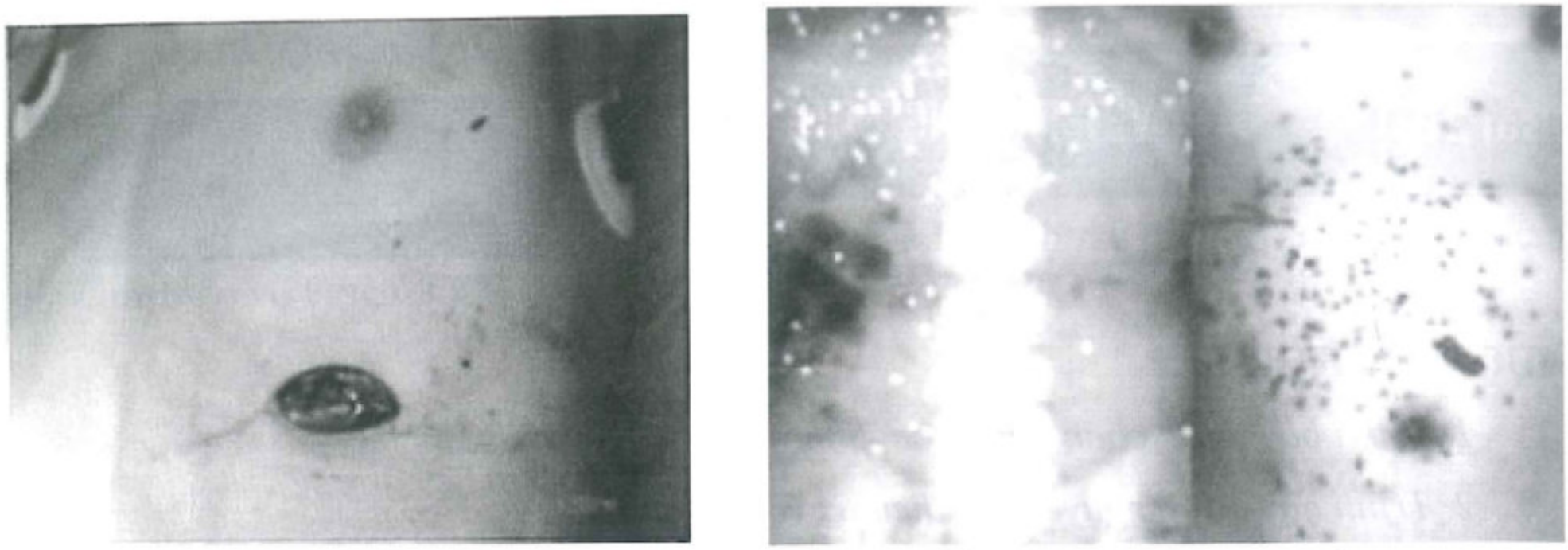
Có hai loại tác nhân gây vết thương bụng với mức độ tổn thương khác nhau:

- Vết thương do bạch khí (vật sắc nhọn đâm): Vết thương gọn, thường chỉ có lỗ vào và dễ định hướng tổn thương.
- Vết thương do hỏa khí: Thường nhiều tạng bị tổn thương, phức tạp và khó đánh giá.

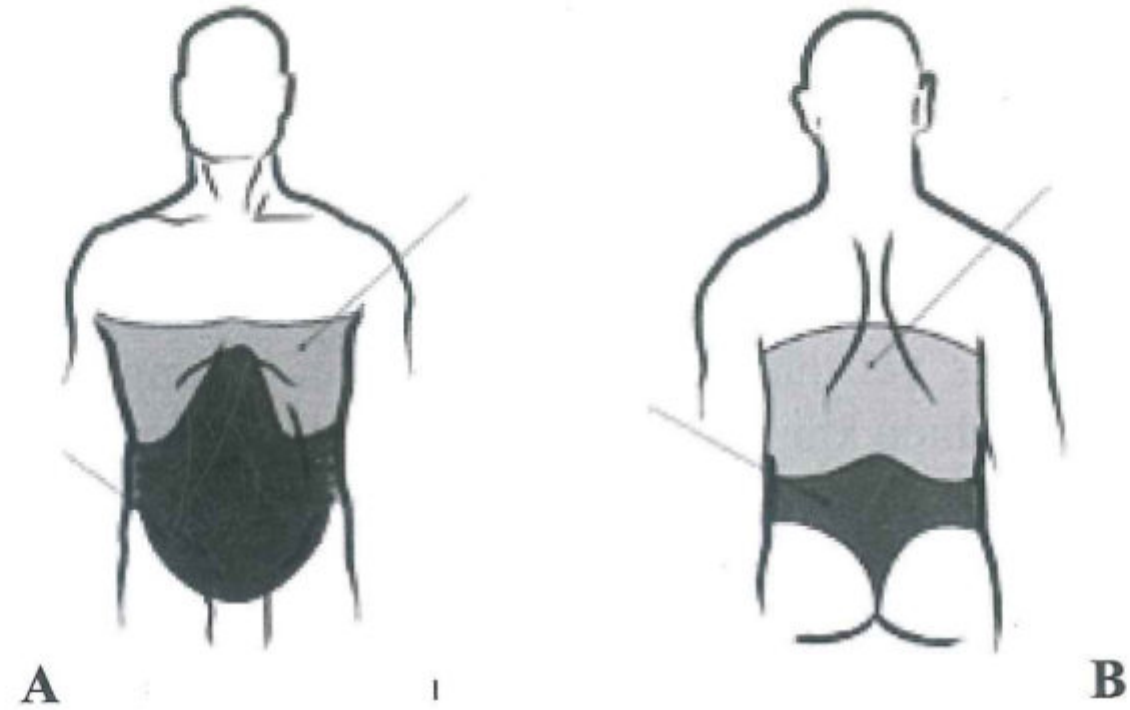
2.2. Mức độ tổn thương

- Tổn thương thành bụng: Tổn thương gây rách da, lớp dưới da đến lớp cơ và rách lá phúc mạc thành. Vị trí tổn thương thành bụng được chia thành ba vùng: vùng bụng trước (từ mũi ức đến xương mu, nằm trong giới hạn của hai đường nách trước); vùng lưng (từ bờ dưới sườn hai bên ở phía sau đến mào chậu, nằm giữa hai đường nách trước); Vùng ngực bụng trước và sau (từ núm vú hai bên đến bờ dưới sườn hai bên).

zalo nhóm duy nhất 0528112107



Hình 1. Vết thương bụng: A. Do bạch khí; B. Do hỏa khí



Hình 2. Phân loại tổn thương thành bụng.

A. thành bụng trước: Chia hai vùng: Vùng ngực bụng (trên), vùng bụng trước (dưới);

B. thành bụng sau: Chia hai vùng: Vùng ngực bụng (trên), vùng lưng (dưới)

Tổn thương các tạng trong ổ bụng:

- Dạ dày, ruột có thể bị thủng một hay nhiều lỗ, lỗ thủng to hay nhỏ tùy theo tác nhân.

- Tá tràng và đại tràng, trực tràng có thể bị thủng trong hay ngoài phúc mạc, tổn thương ngoài phúc mạc khó chẩn đoán, dễ bỏ sót khi vết thương từ phía sau vào qua khối cơ lưng dày, lỗ vào nhỏ, không được thăm dò chính xác.

- Tổn thương sau phúc mạc thường nhanh chóng dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn nhiễm độc do viêm tấy lan tỏa khoang tế bào sau phúc mạc gây bởi các vi khuẩn ái khí và kị khí.

- Gan, lách, tụy, thận: Tổn thương có thể đơn giản nếu ở ngoại vi, nông, nhỏ hoặc có khi rất phức tạp nếu tổn thương sâu, rộng và rách đường bài xuất (đường mật, ống tụy, đài bể thận).

- Bàng quang bị rách trong hay ngoài phúc mạc.

- Mạch máu: Đường đi của tác nhân có thể làm rách hoặc đâm xuyên qua mạch máu lớn gây hội chứng chảy máu trong ổ bụng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

II. TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

1. Trường hợp dễ chẩn đoán

Khi vết thương bụng có lòi tạng hay mạc nối lớn, hoặc qua vết thương có chảy dịch của một tạng nào đó trong bụng, như dịch tiêu hóa, thức ăn, dịch mật, nước tiểu, phân…



Hình 3. Vết thương thành bụng trước có lòi mạc nối lớn

2. Trường hợp khó chẩn đoán

Chẩn đoán: Biểu hiện vết thương thành bụng như vết thương phần mềm, kết hợp với một trong hai hội chứng là hội chứng viêm phúc mạc hoặc hội chứng chảy máu trong ổ bụng (đã được viết trong bài chấn thương bụng kín). Để xác định vết thương có thấu bụng hay không, có thể:

- Hoặc thăm dò vết thương thành bụng thấy thủng phúc mạc: Kiểm tra từng lớp của vết thương, hoặc có thể gây tê và mở rộng vết thương để kiểm tra.

- Hoặc nội soi thăm dò ổ bụng thấy thủng phúc mạc (vết thương sâu khó thăm dò).

2.1. Lâm sàng

2.1.1. Hỏi bệnh

- Loại tác nhân gây ra vết thương, hình dạng, kích thước, hướng đi của vết thương giúp nhận định khả năng tổn thương tạng.

- Hoàn cảnh, tư thế bệnh nhân so với tác nhân gây thương tích cũng góp phần giúp định hướng tổn thương.

2.1.2. Triệu chứng cơ năng

- Đau bụng khu trú vùng vết thương hay lan tỏa khắp ổ bụng giúp hướng tới có hay không có tổn thương tạng. Đặc biệt khi vết thương nằm ở vùng bụng trước, đường đi của vết thương rất dễ có tổn thương tạng rỗng, dịch tiêu hóa thoát ra ngoài ổ bụng gây ra biểu hiện đau lan tỏa toàn bộ ổ bụng. Vết thương vùng lưng có thể gây thủng tá tràng, đại tràng lên và đại tràng xuống gây ra biểu hiện đau bụng khu trú và viêm tấy xung quanh.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

- Các triệu chứng nôn ra máu, ỉa ra máu chứng tỏ có tổn thương đường tiêu hóa, đái ra máu biểu hiện tổn thương hệ tiết niệu.

- Nếu vết thương vùng ngực bụng (trước, sau) có tổn thương cơ hoành, bệnh nhân có biểu hiện khó thở do tràn máu, tràn khí màng phổi.

2.1.3. Triệu chứng toàn thân

- - Bệnh nhân có thể trong tình trạng bình thường nếu đến sớm và không có mất máu nhiều. Dựa vào tình trạng huyết động và tình trạng thần kinh, sẽ đánh giá được mức độ mất máu của bệnh nhân tại thời điểm cấp cứu ban đầu:

Bảng 1: Phân loại tình trạng mất máu dựa trên các dấu hiệu toàn thân

	Độ 1	Độ 2	Độ 3	Độ 4
% Máu mất	< 15	15 – 30	30 – 40	> 40
Nhịp tim	< 100	100 -120	120 - 140	> 140
Huyết áp động mạch	Bình thường/ tăng	Giảm	Giảm	Giảm
Nhịp thở	14 – 20	20 – 30	30 – 40	> 35
Tình trạng thần kinh	Lo âu nhẹ	Lo âu vừa	Vật vã	Li bì
Lưu lượng nước tiểu (ml/h)	> 30	20 – 30	5 – 15	Rất ít

- Trong trường hợp tổn thương tạng đặc hoặc mạch máu của mạc treo ruột gây mất máu nhiều thì bệnh nhân sẽ ở trong tình trạng sốc, nặng hay nhẹ tùy mức độ máu mất.

- Nếu tổn thương tạng rỗng hoặc vết thương đến muộn, bệnh nhân có biểu hiện của hội chứng nhiễm trùng. Nếu là vết thương đại tràng, tình trạng nhiễm độc có thể xuất hiện sớm do dịch phân tràn vào ổ bụng hoặc ra khoang sau phúc mạc.

2.1.4. Triệu chứng thực thể

- Khám vết thương: Đánh giá số lượng, kích thước, vị trí, đường đi của vết thương, hướng đi của tác nhân đồng thời xem có dịch gì chảy qua vết thương.

- Khám bụng: Đánh giá tình trạng ổ bụng theo hai loại tổn thương tạng (đặc và rỗng) với hai hội chứng (chảy máu trong và viêm phúc mạc) tương tự như trong chấn thương bụng (tham khảo bài Chấn thương bụng).

2.2. Cận lâm sàng

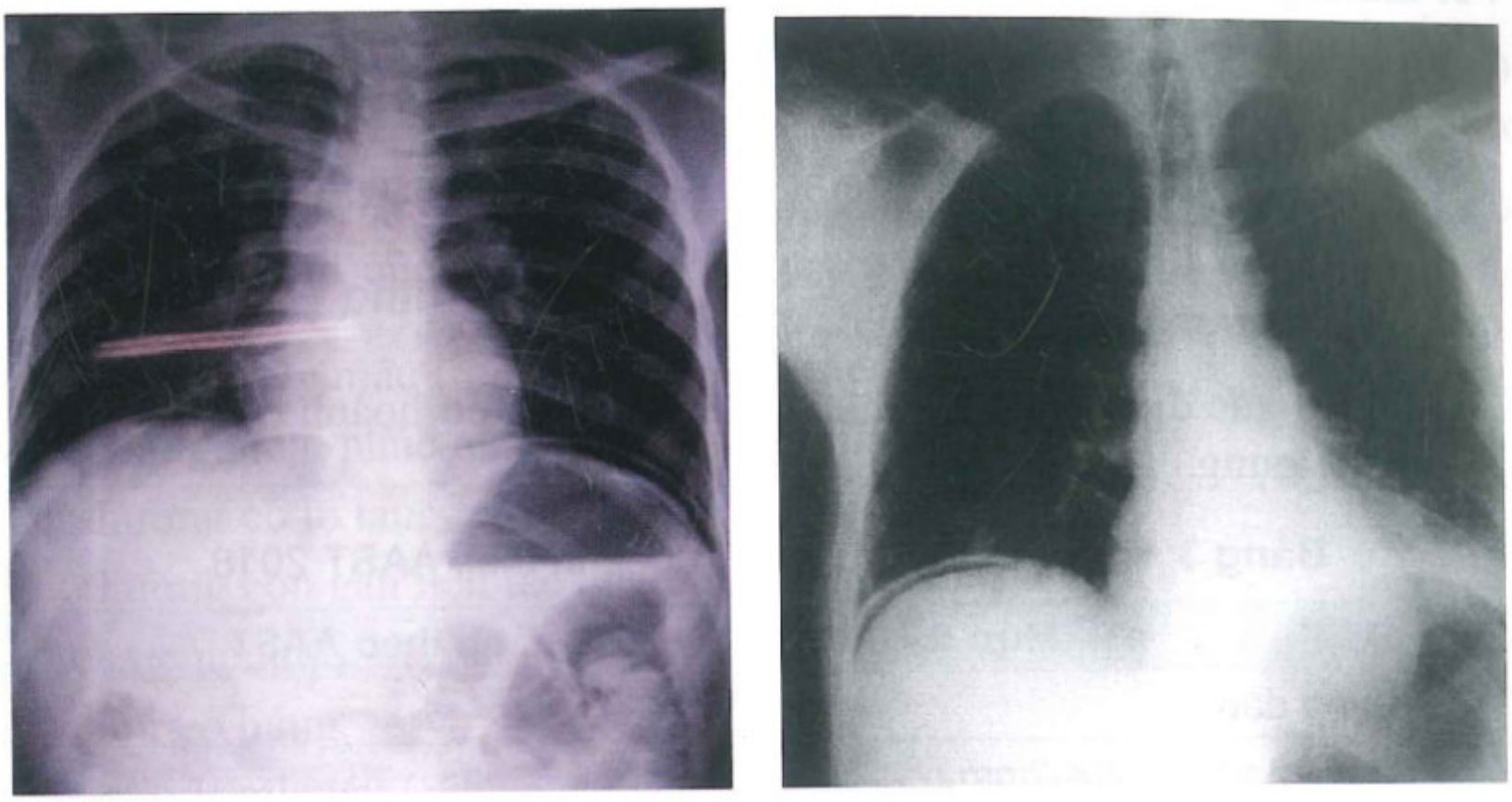
- *X quang bụng không chuẩn bị:* Nếu thấy liềm hơi thì chắc chắn là vết thương thấu bụng. Có thể thấy dị vật trong trường hợp vết thương do hỏa khí (viên đạn, mảnh đạn).

- *Siêu âm*:

Nếu bệnh nhân có huyết động không ổn định cần phải xử trí mổ cấp cứu ngay, siêu âm tại giường giúp định hướng tạng tổn thương theo đường đi của dị vật. : Nếu vỡ tạng đặc sẽ thấy có dịch (máu) trong ổ bụng và hình ảnh vỡ tạng, nếu vỡ tạng rỗng thì thấy có dịch trong ổ bụng.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Nếu bệnh nhân có huyết động ổn định, tiếp tục hồi sức bệnh nhân, sau đó chụp cắt lớp vi tính để đánh giá rõ mức độ tổn thương tạng.



Hình 4. X quang ngực cho thấy liềm hơi dưới vòm hoành

- *Chọc rửa ổ bụng:* Cũng tương tự như trong chấn thương bụng (tham khảo bài Chấn thương bụng) và một trong những phương tiện giúp đưa ra chỉ định phẫu thuật sớm khi có vết thương thấu bụng.

- *Chụp cắt lớp vi tính*: Cho kết quả dịch hay khí ổ bụng, hình ảnh tổn thương tạng rõ ràng hơn so với các thăm dò khác (Tham khảo thêm bài chấn thương bụng kín)

- *Xét nghiệm:* Dựa vào các chỉ số hồng cầu, Hemoglobin, Hematocrit để đánh giá mức độ mất máu, chủ yếu trong trường hợp vết thương bụng có tổn thương mạch trong nhu mô hay mạch mạc treo ruột, hay mạch máu lớn.

Bảng 2: Đánh giá mức độ chảy máu

Chỉ số	Mức độ mất máu		
	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Hồng cầu	>3,5 triệu/mm^3	2,5-3,5 triệu/mm^3	<2,5 triệu/mm^3
Hb	>10 g/l	9-10 g/l	<9 g/l
Hematocrit	>35%	30-35%	<30%

Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, chức năng đông máu được làm thường qui.

III. ĐIỀU TRỊ

Trong vết thương bụng, để quyết định chiến lược điều trị, vùng bụng được chia thành các phần như đã trình bày: Vùng bụng trước (từ mũi ức đến xương mu, nằm trong giới hạn của hai đường nách trước); vùng lưng (từ bờ dưới sườn hai bên phía sau lưng đến mào chậu, nằm giữa hai đường nách trước); Vùng ngực bụng (từ núm vú hai bên đến bờ dưới sườn hai bên) bao gồm phần ngực bụng trước và phần ngực bụng sau.

zalo nhóm duy nhất 0528112107

1. Vết thương vùng ngực bụng

- Vết thương vùng này dễ gây tổn thương cả ngực và bụng, bao gồm cơ hoành.

- Chấn thương cơ hoành chẩn đoán dễ hơn vết thương cơ hoành do dao đâm bởi vết thương đâm thường nhỏ.

- Chẩn đoán tổn thương cơ hoành dựa trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực bụng: Hình ảnh gián tiếp là tổn thương tạng gần cơ hoành, tổ chức mỡ trong khoang bụng thoát vị qua lỗ tổn thương; cơ hoành bị dày lên kèm tụ máu.

- Chẩn đoán xác định trực tiếp mức độ tổn thương cơ hoành dựa vào nội soi lồng ngực hoặc nội soi bụng.

Bảng 3: Phân độ tổn thương cơ hoành theo AAST 2018

Độ	Mức độ thương tổn cơ hoành theo AAST
I	Đụng dập
II	Đường vỡ/ rách < 2 cm
III	Đường vỡ/ rách từ 2 - 10 cm
IV	Đường vỡ/ rách > 10 cm, có kèm theo mất tổ chức ≤ 25 cm^2
V	Đường vỡ/ rách kèm theo mất tổ chức > 25 cm^2
*Tăng 01 độ cho những trường hợp tổn thương hai bên từ độ III trở xuống.	

2. Vết thương vùng lưng

Vết thương thường ít tổn thương nặng, khó chẩn đoán tổn thương bằng lâm sàng. Chụp cắt lớp vi tính được chỉ định khi huyết động của bệnh nhân ổn định sẽ giúp đánh giá tương đối chính xác tổn thương. Mặt khác, với máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy có thể dựng được đường đi của dị vật.

Bảng 4: Tổn thương tạng khi có vết thương vùng lưng

Nguy cơ	Tổn thương trên CLVT	Xử trí
Thấp	Không có thấu bụng hoặc tổn thương tổ chức dưới da	Theo dõi
Trung bình	- Vết thương thấu vào cơ - Tổn thương gây tụ máu khoang sau phúc mạc, nhưng không gây tổn thương tạng và mạch máu lớn	Theo dõi sát lâm sàng
Cao	- Thoát thuốc lớn từ thận - Thoát thuốc cản quang từ đại tràng - Tụ máu lớn ngay sát các mạch máu lớn sau phúc mạc - Khí tự do khoang sau phúc mạc không có nguồn gốc từ đường vào của dị vật - Có bằng chứng tổn thương trên và dưới cơ hoành - Dịch tự do trong ổ bụng	Phẫu thuật

zalo nhóm duy nhất 0528112107

Như vậy, chỉ định phẫu thuật được quyết định dựa trên mức độ tổn thương trên phim cắt lớp vi tính.

3. Vết thương vùng bụng trước

Khoảng 50 - 75% vết thương (do vật sắc nhọn) thấu vào khoang phúc mạc, trong số đó 50 - 75% cần phải phẫu thuật.

3.1. Chỉ định điều trị phẫu thuật

- Hội chứng chảy máu trong ổ bụng kèm theo sốc.
- Hội chứng viêm phúc mạc (tác nhân làm thủng ruột).
- Vết thương có lộ tạng (mạc nối lớn, ruột non, đại tràng…).
- Vết thương còn gắn liền tác nhân trên bụng.
- Có chảy máu tươi qua sonde dạ dày hoặc qua hậu môn.
- Chọc rửa ổ bụng:

+ Hút ra > 10ml máu / dịch mật / dịch tiêu hóa / thức ăn → ***Chỉ định mổ cấp cứu***

+ Nếu không hút được ra, tiến hành truyền 1 lít huyết thanh ấm vào ổ bụng sau đó rút dịch ra xét nghiệm: > 100.000 hồng cầu/mm^3 ; > 500 bạch cầu/mm^3; Amylase/ Alkaline Phosphatase/ Bilirubin tăng lên, có biểu hiện thủng tạng rỗng hoặc có chảy máu tiếp diễn.

3.2. Chỉ định điều trị bảo tồn và theo dõi

- Đánh giá tình trạng bệnh nhân 6 tiếng/lần: Các dấu hiệu toàn thân và tình trạng bụng.
- Theo dõi: Công thức máu, siêu âm bụng.
- Thời gian theo dõi: 24 tiếng
- Biểu hiện tiến triển tốt: Dấu hiệu toàn thân ổn định, bụng đỡ đau, bệnh nhân ăn được và có lưu thông tiêu hóa.
- Hồi sức chống sốc (nếu có): Bù khối lượng tuần hoàn, giảm đau, chống suy hô hấp.

3.3. Sơ cứu vết thương bụng có lòi tạng

- Lau rửa vết thương, tạng lòi ra bằng dung dịch NaCl $9^0/_{00}$ vô khuẩn.
- Dùng hộp hay bát sạch vô trùng càng tốt che bọc phía ngoài tạng bị lộ để băng ép lên trên không để tạng tiếp tục lòi ra ngoài, tránh nguy cơ hoại tử tạng trong thời gian chuyển tới tuyến chuyên khoa.

+ Giảm đau tốt cho bệnh nhân tránh gây sốc do đau.

+ Tiêm phòng uốn ván và dùng kháng sinh dự phòng cho bệnh nhân.

Trường hợp bệnh nhân có sốc thì tiến hành phối hợp chống sốc bao gồm bù khối lượng tuần hoàn và giảm đau, vận chuyển nhẹ nhàng.

3.4. Điều trị phẫu thuật

- Nguyên tắc phẫu thuật: Thăm dò tỉ mỉ, toàn diện, có hệ thống các tạng trong ổ bụng. Hiện nay, có thể dùng phẫu thuật nội soi chẩn đoán trong vết thương bụng để phát

zalo nhóm duy nhất 0528112107

hiện các tạng bị tổn thương và xử trí một số trường hợp tổn thương không quá phức tạp.

- Phương pháp gây mê: Về nguyên tắc, vết thương bụng phải điều trị bằng phẫu thuật và gây mê toàn thân có giãn cơ là cần thiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi vết thương nhỏ, không thấy rõ triệu chứng của vết thương thấu bụng có thể áp dụng gây tê tại chỗ rồi mở rộng vết thương để kiểm tra, nếu phúc mạc không rách tức là một vết thương thành bụng sẽ xử lý như vết thương phần mềm, nếu có rách phúc mạc thì sẽ mở bụng.

- Đường mổ: Thông thường nhất vẫn là đường giữa trên dưới rốn. Trong một số tình huống cụ thể, có thể mở rộng từ vết thương hay một đường mổ gần vết thương.

- Giải quyết tổn thương: Cách xử lý tương tự như trong chấn thương bụng (tham khảo bài Chấn thương bụng).

IV. KẾT LUẬN

Vết thương bụng vẫn còn khá thường gặp hiện nay. Chẩn đoán chính xác vết thương thấu bụng hay vết thương thành bụng là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa quyết định phương pháp điều trị cụ thể. Phẫu thuật vẫn giữ vai trò quan trọng trong điều trị vết thương thấu bụng và xử trí tùy thuộc vào tổn thương cụ thể của từng tạng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Charles Brunicardi F., Dna K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Raphael E. Pollock. (2006). Trauma. Schwartzs manual of surgery, eighth edition, p. 97-137. *McGraw-Hill Companies, Medical Publishing Division, United States of America.*
2. Juan A. Asensio, and Donald D. Trunkey. (2008). Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. *Mosby, Inc., an affi liate of Elsevier Inc.*
3. Judith E. Tintinalli, Stephan Stapczynski J., David M. Cline, John Ma O., Rita K. Cydulka, and Garth D. Meckler. (2011). Abdominal trauma. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, seventh edition. *The McGraw-Hill Companies, Inc, China.*
4. Morris Peter J., Wood William C. (2000). The abdomen section. Oxford Textbook of Surgery, 2nd Edition. *Oxford University Press.*
5. Peter F. Mahoney, James M. Ryan, Adam J. Brooks and William Schwab C. (2005) Abdomen and pelvis. Ballistic Trauma: A practical guide, Second Edition. *SpringerVerlag London Limited.*
6. Sabiston David C., Townsend Courtney M. *Mamagement of acute trauma.* Townsend.
7. Sabiston Textbook of Surgery, (2012). 19th ed. *Saunders, An Imprint of Elsevier.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày chẩn đoán xác định và phân loại vết thương bụng?

Câu 2. Hãy trình bày nguyên tắc điều trị vết thương bụng?

zalo nhóm duy nhất 0528112107